

CAPÍTULO 11.17

SIADH (Síndrome de Secreción Inadecuada de ADH)

PERFIL EUNACOM 1.03.1.015

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción al Síndrome Polidíptico Poliúrico

- El **síndrome polidíptico poliúrico** se define por la presencia de dos síntomas cardinales que suelen retroalimentarse:
- **Polidipsia:** Sed excesiva que lleva a una ingesta aumentada de líquidos.
- **Poliuria:** Eliminación de grandes volúmenes de orina (generalmente >3 litros en 24 horas en adultos).

Clínicamente, el desafío es determinar qué ocurrió primero: ¿El paciente tiene sed y por eso orina mucho (causa primaria), o el paciente pierde agua por el riñón y la sed es una respuesta compensatoria (causa secundaria)?

Algoritmo Diagnóstico: Los 3 Pilares

El estudio de este síndrome se realiza de forma escalonada utilizando tres exámenes fundamentales:

- **Glicemia de Ayuno:** Es el primer paso obligatorio. Su objetivo es descartar **Diabetes Mellitus tipo 2** o **Diabetes Mellitus tipo 1**, que es la causa más frecuente de poliuria osmótica.
- **Test de la Sed (Test de privación de agua):** Se utiliza cuando la glicemia es normal. Permite diferenciar entre la **Polidipsia Primaria** (o psicógena) y la **Diabetes Insípida (DI)**.
- **Test de Desmopresina:** Se realiza una vez confirmado el diagnóstico de Diabetes Insípida para diferenciar si el origen es **Central** (falta de producción de ADH) o **Nefrogénico** (resistencia renal a la ADH).

El Test de la Sed (Privación de Agua)

Este test evalúa la capacidad del cuerpo para concentrar la orina cuando se le priva de líquidos. Se miden la **natremia** (sodio en sangre), la **osmolaridad plasmática** y la **osmolaridad urinaria**.

TABLA 11.17.1: PARÁMETRO VS POLIDIPSIA PRIMARIA (PSICÓGENA)		
PARÁMETRO	POLIDIPSIA PRIMARIA (PSICÓGENA)	DIABETES INSÍPIDA (DI)
Fisiopatología	Ingesta excesiva de agua → Supresión de ADH.	Déficit de ADH o resistencia renal.
Natremia Basal	Normal o levemente baja (dilución).	Normal (compensada por sed) o alta.
Osmolaridad Urinaria Basal	Disminuida (orina muy diluida).	Disminuida (orina muy diluida).
Tras Privación de Agua	Normaliza todo. El sodio sube a rangos normales y la orina se concentra.	No concentra. El sodio sube (hipernatremia) y la orina sigue diluida.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Si un paciente presenta **hipernatremia basal** y orina diluida, el diagnóstico de Diabetes Insípida es directo. **No se debe realizar el test de la sed** en estos pacientes, ya que privarlos de agua sería peligroso y redundante.

NOTA CLÍNICA

En la polidipsia primaria, el riñón es sano. Al dejar de tomar agua, la hormona antidiurética (ADH) se activa normalmente y el paciente deja de orinar en exceso. En la DI, aunque el paciente se deshidrate, el riñón sigue perdiendo agua porque la señal de la ADH no está o no funciona.

Test de Desmopresina

Una vez que el test de la sed confirma una Diabetes Insípida (el paciente no concentró la orina a pesar de la deshidratación), debemos localizar el problema. La **Desmopresina** es un análogo sintético de la vasopresina (ADH).

- **Diabetes Insípida Central:** Existe un déficit en la producción de ADH en el hipotálamo o su liberación en la neurohipófisis.
- - **Resultado:** Al administrar desmopresina, el paciente **responde positivamente**, su orina se concentra y disminuye la poliuria.
- **Diabetes Insípida Nefrogénica:** El riñón es incapaz de responder a la ADH.
- - **Resultado:** Al administrar desmopresina, el paciente **no mejora**. La orina sigue diluida porque el receptor renal no funciona.

Etiología y Manejo Clínico

1. Diabetes Insípida Central

Es causada por cualquier daño a las estructuras que producen o almacenan ADH. - **Causas:** Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) —la más frecuente—, tumores (germinomas, craneofaringiomas), o cirugías de la base del cráneo. - **Tratamiento:** Reposición del análogo faltante con **Desmopresina** (generalmente vía nasal u oral).

2. Diabetes Insípida Nefrogénica

El riñón es el problema. - **Causas:** - **Fármacos:** El **Litio** es la causa clásica en pacientes psiquiátricos. - **Trastornos metabólicos:** **Hipercalcemia** severa (el calcio interfiere con la acción de la ADH en el túbulo). - **Genéticas:** Mutaciones en receptores de ADH. - **Tratamiento:** 1. Asegurar ingesta libre de agua para evitar la deshidratación severa. 2. **Hidroclorotiazida** y **AINes**.

NOTA CLÍNICA

¿Por qué usar diuréticos (tiazidas) y AINes para tratar la poliuria?

Aunque parezca paradójico, estos fármacos aumentan la reabsorción de agua en los segmentos **proximales** de la nefrona (túbulo contorneado proximal). Como la ADH actúa en el túbulo colector (distal), al reabsorber más agua antes de llegar ahí, disminuye el volumen total de orina final.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En un examen, si te presentan un paciente con trastorno bipolar en tratamiento con **Litio** que consulta por mucha sed y orina, sospecha siempre una **Diabetes Insípida Nefrogénica**. Si el paciente tiene una patología psiquiátrica pero **NO** toma litio, considera la **Polidipsia Psicógena**.

Complicaciones Graves

El mayor riesgo del síndrome polidíptico poliúrico (especialmente en la DI) es la **hipernatremia severa** si el paciente no tiene acceso libre a agua.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La hipernatremia extrema puede provocar deshidratación neuronal, lo que lleva a la ruptura de vasos sanguíneos cerebrales y **hemorragia intracraneana**. Siempre se debe garantizar el acceso a líquidos en pacientes con DI nefrogénica.

Resumen de conceptos clave para EUNACOM

- **Diabetes Mellitus:** Poliuria osmótica (primera causa a descartar con glicemia).

- **Polidipsia Primaria:** Natremia baja/normal. Corrige con el test de la sed.
- **DI Central:** Falta ADH. Mejora con Desmopresina. Asociada a TEC/Cirugía.
- **DI Nefrogénica:** Resistencia a ADH. No mejora con Desmopresina. Asociada a Litio/Hipercalcemia. Tratamiento con tiazidas/AINEs.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 60 años con cáncer pulmonar de células pequeñas presenta sodio sérico de 118 mEq/L y osmolaridad urinaria de 450 mOsm/kg. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento de primera línea?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para SIADH (Síndrome de Secreción Inadecuada de ADH). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- SIADH: exceso de ADH retiene agua y produce hiponatremia.
- Causas: alteraciones del SNC, patologías pulmonares, tumores, postquirúrgico (dolor, vómitos).
- Diagnóstico: hiponatremia + orinas concentradas (osmolaridad urinaria mayor a 200).
- Tratamiento fundamental: restricción de agua libre, máximo 800 cc/día (todo líquido incluido).
- Las natremias dependen del balance de AGUA, no del balance de sodio.
- Furosemida puede ayudar como adyuvante (alto clearance de agua libre).
- SIADH y diabetes insípida son absolutamente lo opuesto.
- Paciente postquirúrgico con dolor/vómitos + hiponatremia = pensar SIADH.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SIADH (SÍNDROME DE SECRECIÓN INADECUADA DE ADH))

PREGUNTA 1

Paciente de 60 años con cáncer pulmonar de células pequeñas presenta sodio sérico de 118 mEq/L y osmolaridad urinaria de 450 mOsm/kg. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento de primera línea?

- A)** SIADH. Suero hipertónico de urgencia
- B)** SIADH. Restricción de agua libre a máximo 800 cc/día
- C)** Diabetes insípida. Desmopresina
- D)** SIADH. Suero fisiológico en bolos
- E)** Insuficiencia suprarrenal. Hidrocortisona

PREGUNTA 2

Paciente recién operado de hernia inguinal presenta náuseas, vómitos y sodio de 128 mEq/L al día siguiente. ¿Cuál es la causa más probable de la hiponatremia?

- A)** Pérdida de sodio por vómitos
- B)** SIADH postquirúrgico por dolor y vómitos
- C)** Sobrehidratación con suero glucosado
- D)** Insuficiencia renal aguda
- E)** Hipotiroidismo

PREGUNTA 3

¿Cuál de los siguientes diuréticos puede utilizarse como adyuvante en el tratamiento del SIADH?

- A)** Hidroclorotiazida
- B)** Espironolactona
- C)** Furosemida
- D)** Amilorida
- E)** Acetazolamida

RESUMEN: SIADH (SÍNDROME DE SECRECIÓN INADECUADA DE ADH)

El SIADH se produce por exceso de hormona antidiurética, que retiene agua y causa hiponatremia. La clínica va desde asintomática hasta cefalea, edema cerebral, compromiso de conciencia. Las causas incluyen alteraciones del SNC (TEC, meningitis), patologías pulmonares (TBC, bronquiectasias, TEP, cáncer pulmonar), tumores, y situaciones agudas postquirúrgicas (dolor, náuseas, vómitos). El diagnóstico requiere hiponatremia más orinas concentradas (osmolaridad urinaria mayor a 200 mOsm), lo que indica que se retiene agua (sangre diluida con orinas concentradas = insuficiente clearance de agua libre). El tratamiento fundamental es la restricción de agua libre (máximo 800 cc/día, incluyendo todo líquido). Las natremias dependen del balance de agua, no de sal. La furosemida puede ayudar como adyuvante (alto clearance de agua libre). La sal puede servir a largo plazo pero no es lo fundamental. SIADH y diabetes insípida son absolutamente lo opuesto.